



Guía de Primeros Auxilios y Emergencias

Faro VE — Mapa de Esperanza · Venezuela

34 guías paso a paso · información de fuentes oficiales

IFRC/Cruz Roja · AHA · OMS · CDC · OPS · UNICEF · Mayo Clinic · FUNVISIS/Protección Civil

Actualizada el 27 de junio de 2026 · faro-ve.com

Contenido en revisión. Es información general de fuentes oficiales (Cruz Roja/IFRC, AHA, OMS, CDC, FUNVISIS) y NO reemplaza la atención de un profesional de salud. Ante una emergencia, llama al 911.

Comparte esta guía libremente. Puede ayudar a salvar una vida.

Primeros auxilios

Qué hacer en los primeros minutos. Si puedes, pide que alguien llame al 911 mientras tú ayudas.

1 Sangrado fuerte (hemorragia)

Cómo detener una herida que sangra mucho.

PASOS

1. Si puedes, ponte guantes o usa una bolsa de plástico limpia en tu mano para protegerte.
2. Recuesta a la persona y, si es posible, levanta la parte que sangra por encima del nivel del corazón.
3. Cubre la herida con una gasa o un trapo limpio y presiona fuerte y directo con la palma de tu mano, sin soltar, hasta que pare el sangrado.
4. Si la sangre traspasa el trapo, NO lo quites: pon otra gasa o trapo encima y sigue presionando firme.
5. Cuando pare, deja el vendaje puesto y mantén a la persona quieta y tranquila mientras llega la ayuda.

QUÉ NO HACER

- No presiones sobre un ojo lastimado ni sobre un objeto clavado.
- No saques objetos grandes o clavados profundo (pueden estar tapando la herida y frenando la sangre).
- No quites el primer trapo aunque se empape: agrega más encima.
- No hurgues dentro de la herida.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Si la sangre sale a chorros o no para con la presión.
- Si la herida es profunda o grande, o hay un objeto clavado.
- Si la persona se pone pálida, fría o confundida (signo de shock).

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Sangrado severo: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-severe-bleeding/basics/art-20056661>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

2 Sangrado de brazo o pierna que no para: torniquete

Para sangrado muy fuerte en un brazo o una pierna (aplastamiento, amputación) que NO se detiene apretando la herida. El torniquete salva la vida.

PASOS

1. Llama al 911 de una vez (o pide a alguien que llame). Por una pérdida de sangre así una persona puede morir en pocos minutos: actúa rápido.
2. Primero aprieta la herida: pon un trapo limpio o tu mano directo sobre ella y aprieta fuerte sin soltar. Muchas veces el sangrado para solo con esto.
3. Si la sangre NO para y es en un brazo o una pierna, ahí sí usa un torniquete. El torniquete es SOLO para brazos y piernas; nunca en el cuello ni en el tronco (pecho o barriga).
4. Coloca el torniquete unos 5 a 7 cm por ARRIBA de la herida (entre la herida y el corazón), nunca encima de la herida ni sobre una articulación (codo, rodilla, muñeca o tobillo). Si no ves bien la herida, ponlo lo más arriba posible del brazo o la pierna.
5. Aprieta lo más fuerte que puedas hasta que la sangre PARE. Avisa que va a doler, pero es necesario.
6. ANOTA LA HORA en que lo pusiste: escríbela en el torniquete o en la piel de la persona (por ejemplo en la frente) para que los rescatistas la vean.
7. NO lo aflojes ni lo quites. Una vez puesto, debe quedarse así hasta que llegue el personal médico.
8. Si no tienes un torniquete de verdad, improvisa: usa una tela ancha (al menos 4 cm de ancho, como una tira de camisa) amarrada arriba de la herida, mete un palo firme y tuércelo para apretar hasta que pare la sangre; amarra el palo para que no se suelte.
9. Mantén a la persona acostada y abrigada mientras llega la ayuda.

QUÉ NO HACER

- No uses cordón fino, cable, alambre ni cordones de zapato: cortan la piel y no detienen bien la sangre.
- No pongas el torniquete en el cuello ni en el tronco: solo sirve en brazos y piernas.
- No lo coloques encima de la herida ni sobre una articulación; ponlo más arriba.
- No lo aflojes ni lo quites para 'revisar': puede volver a sangrar fuerte.
- No pierdas tiempo: si la sangre no para con presión en un brazo o pierna, pon el torniquete sin demora.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- El sangrado es muy fuerte y no para aunque aprietes la herida.
- La sangre sale a chorros o empapa rápido la ropa o el trapo.
- Un brazo o una pierna quedó aplastado, cortado o arrancado.
- La persona se pone pálida, fría, sudorosa, mareada o se desmaya.
- Tuviste que poner un torniquete: siempre se llama al 911 después.

FUENTES OFICIALES:

American College of Surgeons · Stop the Bleed — Cómo controlar una hemorragia (torniquete)

<https://www.stopthebleed.org/>

Cruz Roja Americana — Sangrado externo que amenaza la vida

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/bleeding-life-threatening-external>

3 RCP en un adulto (solo con las manos)

Si un adulto no responde y no respira normal.

PASOS

1. Verifica si responde: sacúdele el hombro y grítale "¿estás bien?". Si no responde y no respira normal (o solo jadea), actúa.
2. Llama YA al 911 (o pide a alguien que llame) y consigue un desfibrilador (DEA) si hay uno cerca.
3. Arrodíllate al lado de la persona, que esté boca arriba sobre una superficie firme.
4. Coloca el talón de una mano en el CENTRO del pecho (sobre el esternón) y la otra mano encima, entrelazando los dedos.
5. Con los brazos rectos, empuja FUERTE y RÁPIDO hacia abajo: al menos 5 cm de profundidad (sin pasar de 6 cm), a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto.
6. Deja que el pecho suba completo entre cada compresión (no te apoyes encima).
7. No pares. Sigue hasta que llegue la ayuda, aparezca un DEA, o la persona despierte o respire.

QUÉ NO HACER

- No te detengas a revisar el pulso una y otra vez: si no responde y no respira normal, comprime.
- No comprimas suave ni lento: debe ser fuerte y rápido.
- Si no tienes entrenamiento, no es necesario dar respiraciones boca a boca: solo manos.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Siempre, ANTES de empezar, o que alguien llame al 911 mientras tú comprimes.

FUENTES OFICIALES:

American Heart Association (AHA) — RCP solo con las manos (Hands-Only CPR) — Guías 2020

<https://cpr.heart.org/en/resources/what-is-cpr>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

4 RCP en niño y bebé

RCP para un niño (1 año hasta la pubertad) o un bebé (menos de 1 año) que no responde y no respira normal. En ellos casi siempre falta el aire, por eso SÍ se dan respiraciones.

PASOS

1. Mira si reacciona: a un niño tócale el hombro y llámalo fuerte; a un bebé dale golpecitos suaves en la planta del pie (nunca lo sacudas). Si no se mueve, no llora y no respira (o solo da boqueadas raras), necesita RCP ya.
2. Pide ayuda y llama al 911. Si hay alguien contigo, mírale a los ojos y dile: 'Tú, llama al 911 ahora y busca un desfibrilador'. Pon el teléfono en altavoz para que te guíen.
3. Si estás solo y NO viste cuando se desmayó, da primero 2 minutos de RCP y recién después llama al 911 (en niños y bebés casi siempre falla primero la respiración).
4. Acuéstalo boca arriba sobre algo firme. En un bebé, cuídalo siempre la cabeza y el cuello.
5. Coloca las manos. NIÑO: el talón de UNA mano en el centro del pecho (o las DOS, una sobre otra, si te cuesta hundir bien). BEBÉ: lo mejor es rodear el pecho con las dos manos y apretar con los dos PULGARES en el centro, justo debajo de la línea de los pezones; si no logras rodearlo, usa dos dedos en ese mismo punto.
6. Aprieta fuerte y rápido hacia abajo. NIÑO: hunde el pecho unos 5 cm (como un tercio del grosor del pecho). BEBÉ: hunde unos 4 cm (también un tercio). Deja que el pecho suba del todo entre cada apretón.
7. Lleva un ritmo de 100 a 120 apretones por minuto (rápido, como 2 por segundo).
8. Haz 30 apretones y luego 2 respiraciones de rescate: en el NIÑO inclínale un poco la cabeza, tápale la nariz y sopla por la boca; en el BEBÉ cubre con tu boca su boca y nariz a la vez. Cada soplo dura como 1 segundo, solo hasta ver que el pecho sube un poco.
9. Sigue sin parar repitiendo el ciclo: 30 apretones y 2 respiraciones, una y otra vez.
10. No pares hasta que llegue ayuda o un desfibrilador, el niño se mueva o respire, o estés agotado. Si llega un desfibrilador, enciéndelo y sigue lo que la voz indique.

QUÉ NO HACER

- No soples muy fuerte ni le llenes el pecho de aire: solo hasta que suba un poco. Soplar de más le hace daño.
- No aprietes demasiado suave por miedo: el pecho debe hundirse de verdad (un tercio del grosor).
- No dejes de apretar largo rato para revisarlo: cada pausa le quita oxígeno. Solo lo justo para dar las 2 respiraciones.
- En un bebé no uses la fuerza de las dos manos como en un adulto: usa los dos pulgares rodeando el pecho (o, si no puedes rodearlo, dos dedos).
- No pierdas tiempo buscando el pulso si no sabes: si no responde y no respira normal, empieza la RCP.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 apenas veas que un niño o bebé no responde y no respira normal (o solo da boqueadas).
- Si hay otra persona, que llame al 911 de inmediato mientras tú empiezas la RCP sin perder tiempo.
- Si estás solo y NO viste el desmayo: da 2 minutos de RCP y enseguida llama al 911.
- Pon el teléfono en altavoz: en el 911 te pueden guiar paso a paso mientras das RCP.

FUENTES OFICIALES:

5 Atragantamiento en un adulto

Si un adulto se ahoga y no puede hablar, toser ni respirar.

PASOS

1. Pregunta "¿te estás ahogando?". Si no puede hablar, toser ni respirar, o se agarra el cuello, actúa.
2. Ponte a un lado y un poco detrás. Inclínalo hacia adelante.
3. Da 5 golpes firmes en la espalda, entre los omóplatos, con el talón de tu mano.
4. Si no sale el objeto, ponte detrás y rodéale la cintura con tus brazos.
5. Cierra un puño y ponlo con el lado del pulgar contra la barriga, un poco arriba del ombligo. Tómallo con la otra mano.
6. Aprieta la barriga con 5 compresiones rápidas hacia ADENTRO y hacia ARRIBA (esto se llama maniobra de Heimlich).
7. Alterna ciclos de 5 golpes en la espalda + 5 compresiones en la barriga, hasta que salga el objeto o la persona pueda toser o hablar.
8. Si la persona se desmaya, bájala con cuidado a una superficie firme y empieza RCP (compresiones).

QUÉ NO HACER

- No metas los dedos a ciegas en la boca para sacar el objeto (puedes empujarlo más adentro).
- No le des golpes en la espalda sin inclinarlo hacia adelante.
- No le sigas dando agua ni comida.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 apenas empieza el atragantamiento serio (o pide que alguien llame mientras tú ayudas).
- Si se desmaya, es urgente.

FUENTES OFICIALES:

Cruz Roja Americana — Atragantamiento en adultos y niños

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/adult-child-choking>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

6 Atragantamiento en un bebé (menor de 1 año)

Un bebé que se ahoga se atiende distinto a un adulto.

PASOS

1. Si el bebé no puede toser, llorar ni respirar, actúa de inmediato.
2. Acuesta al bebé boca abajo sobre tu antebrazo, apoyando el brazo en tu muslo. La cabeza debe quedar **MÁS BAJA** que el cuerpo. Sostén la cabeza y la mandíbula con tu mano.
3. Da 5 golpes firmes en la espalda, entre los omóplatos, con el talón de tu mano.
4. Voltea al bebé boca arriba, con la cabeza más baja que el cuerpo.
5. Da 5 compresiones en el pecho: pon 2 o 3 dedos en el centro del pecho, en la línea entre los pezones, y empuja hacia abajo unos 4 cm (1½ pulgadas).
6. Alterna 5 golpes en la espalda + 5 compresiones en el pecho hasta que salga el objeto o el bebé tosa o llore.
7. Si el bebé deja de responder, bájalo a una superficie firme y empieza RCP infantil (compresiones).

QUÉ NO HACER

- NUNCA hagas compresiones en la barriga (Heimlich) a un bebé: pueden dañarle el hígado.
- No metas los dedos a ciegas en su boca para buscar el objeto.
- No lo sostengas con la cabeza más alta que el cuerpo durante los golpes.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 de inmediato (o pide que alguien llame mientras tú ayudas al bebé).

FUENTES OFICIALES:

Cruz Roja Americana — Atragantamiento en bebés

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/infant-choking>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

7 Quemaduras

Cómo enfriar y proteger una quemadura.

PASOS

1. Aleja a la persona de la fuente de calor y, si es seguro, quita anillos, pulseras o ropa apretada del área antes de que se hinche (pero NO la ropa pegada a la quemadura).
2. Enfría la quemadura con agua de la llave FRESCA (no helada) corriendo sobre el área por unos 10 minutos.
3. Cubre la quemadura con un vendaje o tela limpia, floja, para protegerla y aliviar el dolor.
4. Si hay dolor, la persona puede tomar un analgésico común de venta libre.

QUÉ NO HACER

- No uses hielo ni agua helada directo sobre la quemadura (daña más la piel).
- No pongas mantequilla, pasta de dientes, aceite ni cremas grasosas (atrapan el calor y aumentan el riesgo de infección).
- No revientes las ampollas.
- No quites la ropa que quedó pegada a la piel quemada.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Si la quemadura es grande o profunda.
- Si afecta cara, manos, pies, genitales o una articulación grande.
- Si es por fuego, electricidad o químicos.
- Si la piel se ve blanca, acartonada, o quemada en círculo alrededor de un brazo o pierna.

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Quemaduras: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

8 Fractura o hueso roto

Si sospechas que un hueso se quebró.

PASOS

1. No muevas a la persona a menos que sea estrictamente necesario (peligro cercano).
2. Si hay sangrado, presiona con una gasa o tela limpia hasta que pare.
3. Inmoviliza la zona lesionada: mantenla quieta en la posición en que está.
4. Si sabes entablillar y la ayuda tardará, coloca una férula (tablilla) sujetando por arriba y por abajo de la zona quebrada.
5. Pon hielo envuelto en una tela (nunca directo sobre la piel) para bajar la hinchazón y el dolor.
6. Vigila signos de shock: si se siente débil o respira corto y rápido, acuéstala y, si puedes, levántale las piernas.

QUÉ NO HACER

- No intentes acomodar el hueso ni empujar hacia adentro un hueso que sobresale.
- No muevas a la persona si sospechas lesión de columna (cuello o espalda).
- No pongas hielo directo sobre la piel.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Si el hueso atravesó la piel o hay sangrado fuerte.
- Si fue por un golpe o accidente grande, o sospechas lesión de cuello o espalda.
- Si la persona no responde o no respira.
- Si la zona se ve azulada o sin pulso ni sensibilidad.

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Fracturas (huesos rotos): primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fractures/basics/art-20056641>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

9 Persona atrapada o aplastada

Muy importante tras un derrumbe: cómo ayudar sin causar más daño.

PASOS

1. Asegura primero tu seguridad: no entres a una estructura inestable; pide ayuda de rescate profesional.
2. Si la persona pudo lesionarse el cuello o la espalda, NO la muevas. Mantenle la cabeza y el cuello quietos: sostén con tus manos o pon toallas o ropa enrolladas a ambos lados del cuello.
3. Habla con la persona, mantenla consciente y tranquila mientras llega el rescate.
4. Si tiene sangrado visible, presiona con tela limpia.
5. ADVERTENCIA: si una parte del cuerpo lleva mucho rato aplastada (varias horas), liberar el peso de golpe puede ser muy peligroso (síndrome de aplastamiento). NO retires el objeto pesado sin la guía del personal de rescate o médico.
6. Si está consciente y NO sospechas lesión de columna ni de pelvis, puedes recostarla y levantarle un poco las piernas.

QUÉ NO HACER

- No muevas ni jales a la persona si sospechas lesión de columna.
- No liberes de golpe el peso que aplasta tras un atrapamiento prolongado, sin guía del rescate.
- No le tuerzas la cabeza ni el cuello.
- Si hay que dar RCP con sospecha de lesión de cuello, no le inclines la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Siempre, de inmediato. Es una emergencia que requiere rescate y atención médica urgente, sobre todo si lleva atrapada más de unos minutos.

FUENTES OFICIALES:

CDC (EE.UU.) — Lesiones por aplastamiento tras un terremoto

<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11904>

Mayo Clinic — Lesión de columna: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-spinal-injury/basics/art-20056677>

10 Shock (gravedad por mala circulación)

Estado peligroso que puede seguir a una herida grave, quemadura o pérdida de sangre.

PASOS

1. Reconoce los signos: piel fría, sudorosa, pálida o grisácea; labios o uñas azulados; pulso rápido; respiración rápida y superficial; debilidad, náuseas o confusión.
2. Llama al 911.
3. Recuesta a la persona boca arriba y levántale las piernas un poco (unos 30 cm), salvo que eso le cause dolor o haya una lesión que lo impida.
4. Mantenla quieta y cómoda; afloja la ropa apretada.
5. Abrígala con una manta o ropa para que no pierda calor (cubre cabeza, manos y pies).

QUÉ NO HACER

- No le des de comer ni de tomar nada.
- No le levantes las piernas si sospechas lesión de columna, pelvis o pierna, o si le causa dolor o le cuesta respirar.
- No la dejes sola.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Siempre. El shock es una emergencia que pone en peligro la vida.

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Shock: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-shock/basics/art-20056620>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

11 Desmayo o persona inconsciente que respira

Cómo poner a alguien de costado (posición de recuperación) para que no se ahogue.

PASOS

1. Si la persona está inconsciente pero RESPIRA y no sospechas lesión de cuello o espalda, ponla de costado para que la vía aérea quede abierta y, si vomita, no se ahogue.
2. Arrodíllate a su lado. Coloca el brazo más cercano a ti en ángulo recto, con el codo doblado y la palma hacia arriba.
3. Pasa el otro brazo cruzando el pecho y apoya el dorso de su mano contra la mejilla del lado tuyo.
4. Dobla la rodilla más lejana hasta que el pie quede apoyado en el piso. Tira de esa rodilla para girar a la persona hacia ti, sobre su costado.
5. Inclina suavemente la cabeza hacia atrás y levanta el mentón para mantener la vía aérea abierta. Vigila que siga respirando.
6. Si solo se desmayó y sigue boca arriba sin lesión: acuéstalo, levántale las piernas unos 30 cm y afloja la ropa apretada.

QUÉ NO HACER

- No la sientes ni la levantes de golpe (puede volver a desmayarse).
- No la pongas de costado si sospechas lesión de columna; en ese caso mantenla quieta como está.
- No le des de comer ni de tomar hasta que esté totalmente recuperada.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Si no recobra el conocimiento en 1 minuto.
- Si no respira (empieza RCP).
- Si se golpeó la cabeza, tiene dolor de pecho, dificultad para respirar, convulsiones, o se desmaya repetidas veces.

FUENTES OFICIALES:

St John Ambulance — Posición de recuperación

<https://www.sja.org.uk/first-aid-advice/recovery-position/>

Mayo Clinic — Desmayo: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fainting/basics/art-20056606>

12 Golpe de calor / deshidratación

Cuando el cuerpo se sobrecalienta: es una emergencia.

PASOS

1. Reconoce el golpe de calor: temperatura muy alta (40 °C o más), piel caliente, confusión o habla enredada, pulso y respiración rápidos, náuseas.
2. Llama al 911 de inmediato.
3. Saca a la persona del calor y llévala a la sombra o a un lugar fresco.
4. Enfríala por cualquier medio: ponla bajo agua fresca, mójala, pásale paños con agua fresca, abanícala, o pon paños húmedos en cuello, axilas e ingle.
5. Si está consciente y puede tragar, dale agua fresca o una bebida con electrolitos (sin alcohol ni cafeína).

QUÉ NO HACER

- No le des líquidos si está inconsciente o muy confundida (riesgo de ahogarse).
- No le des bebidas con alcohol ni cafeína.
- No esperes a que "se le pase": el golpe de calor es una emergencia médica.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Siempre, ante sospecha de golpe de calor (fiebre alta + confusión o pérdida de conocimiento).

FUENTE OFICIAL:

Mayo Clinic — Golpe de calor: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-heatstroke/basics/art-20056655>

13 Convulsión o ataque

Qué hacer mientras alguien convulsiona (se cae, se sacude o se pone rígido sin control).

PASOS

1. Mantén la calma y quédate con la persona todo el tiempo.
2. Mira la hora y empieza a contar cuánto dura: si pasa de 5 minutos, hay que llamar al 911.
3. Aleja cosas peligrosas que tenga cerca (sillas, mesas, objetos con punta o filo) para que no se golpee.
4. Pon algo blando y plano debajo de su cabeza, como ropa doblada, para que no se lastime contra el piso.
5. Afloja lo que tenga apretado en el cuello (camisa, corbata) y, si usa lentes, quítaselos.
6. Cuando deje de convulsionar, voltéala con cuidado de lado, con la boca apuntando hacia el piso, para que la saliva salga sola y no se ahogue.
7. Quédate a su lado mientras despierta: va a estar confundida o cansada. Háblale con calma y explícale qué pasó.

QUÉ NO HACER

- NO le metas nada en la boca (ni dedos, ni cuchara, ni agua): la persona NO se traga la lengua, y meterle algo le rompe los dientes o la hace atragantarse.
- NO la sujetes ni trates de frenar sus movimientos a la fuerza: puede lastimarla a ella o a ti.
- NO le des agua ni comida hasta que esté totalmente despierta.
- NO le des respiración boca a boca durante el ataque: lo normal es que vuelva a respirar sola al terminar.
- NO la dejes sola hasta que esté consciente.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- El ataque dura más de 5 minutos.
- Le viene otro ataque enseguida.
- No despierta o le cuesta respirar después.
- Se golpeó o se lastimó durante el ataque.
- El ataque ocurrió dentro del agua.
- Es la primera vez que esa persona convulsiona.
- Está embarazada, o tiene diabetes y pierde el conocimiento.

FUENTES OFICIALES:

CDC (EE.UU.) — Primeros auxilios para convulsiones

<https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html>

Epilepsy Foundation — Primeros auxilios para convulsiones (Quédate · Protege · De lado)

<https://www.epilepsy.com/recognition/first-aid-resources>

Cruz Roja Americana — Convulsiones: primeros auxilios

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/seizures>

14 Descarga eléctrica o cable de luz caído

Qué hacer si alguien recibe una descarga, o si hay un cable de alta tensión caído tras el sismo.

PASOS

1. PRIMERO TU SEGURIDAD: no toques a la persona si todavía está pegada a la corriente (a un cable, un aparato o agua con electricidad). Si la tocas, la corriente también pasa a tu cuerpo.
2. Si puedes hacerlo sin peligro, corta la electricidad: baja el breaker (la llave o el tablero principal de la luz) o desconecta el aparato del enchufe.
3. Si NO puedes cortar la luz y la persona sigue pegada a la corriente de un aparato del hogar, empújala lejos de la fuente con algo SECO que no pase electricidad (un palo de madera seco, un cartón grueso, un objeto de plástico). Nunca uses algo metálico ni mojado.
4. Si es un CABLE DE ALTA TENSIÓN caído en la calle: aléjate al menos 11 metros (unos 35 pasos largos), y mucho más si los cables saltan o echan chispas. El suelo alrededor puede tener corriente.
5. Da por seguro que TODO cable caído tiene corriente, aunque se vea apagado. No lo toques, no lo muevas con ningún palo, y no toques rejas, cercas, agua ni a alguien que esté pegado al cable.
6. Llama de inmediato a las autoridades (bomberos, la compañía de electricidad o el 911) para que corten la corriente. Solo personal entrenado debe manejar un cable caído.
7. Si vas en carro y un cable cae sobre tu vehículo, quédate adentro: no te bajes. Toca la corneta para pedir ayuda y diles a los demás que no se acerquen.
8. Cuando ya sea seguro, revisa si la persona respira. Si no respira y no se mueve, empieza RCP (compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho) y no pares hasta que llegue ayuda.
9. Cubre las quemaduras (por donde entró y salió la corriente) con una gasa o un paño limpio. No uses cobija ni toalla: sueltan pelusa que se pega.
10. Toda persona que recibió una descarga debe ser revisada por un médico, aunque la quemadura se vea pequeña: el daño por dentro puede ser peor de lo que se ve.

QUÉ NO HACER

- No toques a la persona mientras siga pegada a la corriente.
- No te acerques ni toques un cable de alta tensión caído, aunque parezca apagado.
- No intentes mover un cable de la calle con un palo, escoba ni ningún objeto: la madera o tela mojada también pasan electricidad.
- No te bajes del carro si un cable cayó encima; quédate adentro y pide ayuda.
- No pongas cobija ni toalla sobre las quemaduras.
- No des por sana a la persona aunque se vea bien: necesita revisión médica.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Hay un cable de alta tensión caído (llama también a la compañía de electricidad).
- La persona no respira, no tiene pulso o se desmayó.
- Tiene quemaduras graves, le cuesta respirar, o el corazón le late raro.
- Tiene convulsiones, dolores fuertes de músculos, o está confundida.

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Descarga eléctrica: primeros auxilios

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-electrical-shock/basics/art-20056695>

Electrical Safety Foundation (ESFI) — Seguridad con líneas eléctricas caídas

<https://www.esfi.org/power-lines-safety-tips/>

15 Calmar y acompañar a alguien angustiado

Primeros auxilios psicológicos: cómo acompañar a una persona en shock, con pánico o muy angustiada tras el desastre. El método es observar, escuchar y conectar.

PASOS

1. OBSERVA antes de acercarte: fíjate si el lugar es seguro (estructuras a punto de caer, cables, fuego) y quién está más afectado (personas que tiemblan, lloran sin parar o se quedan ausentes y calladas). Acércate solo si es seguro para ti.
2. Acércate con calma: si tú estás tranquilo, ayudas a que la otra persona se tranquilice. Ve despacio, con voz suave y frases cortas. Ponte a su altura (si está sentada en el piso, agáchate a su lado).
3. Preséntate y ofrece ayuda: di tu nombre y que estás ahí para ayudar. Si no quiere ayuda, no la obligues; dile que puede pedirla después.
4. Llévala a un lugar más seguro y tranquilo, lejos del peligro y, si se puede, del ruido y la multitud. Si tiene frío o está mojada, abrígala.
5. ESCUCHA sin presionar: acompañar no es obligar a hablar. Quédate a su lado y pon atención. Si quiere hablar, escúchala; si prefiere callar, respeta el silencio. No le pidas que cuente lo que vivió.
6. Valida lo que siente: 'entiendo que esto da mucho miedo', 'cualquiera se sentiría así'. No juzgues su reacción aunque sea distinta a la tuya.
7. Si tiene pánico o le cuesta respirar, ayúdala a respirar lento: que tome aire por la nariz despacio sintiendo cómo se le llena la barriga, y que lo bote despacio por la boca. Recuérdale que está a salvo y que el malestar va a ir pasando.
8. Si está muy ida o bloqueada, tráela al presente: con voz calmada pídele que mire alrededor y te diga qué ve, qué oye y qué siente ahora.
9. CONECTA con lo que necesita: agua, un lugar donde sentarse, abrigo, o ayuda para contactar a sus seres queridos. Dale solo información cierta; no inventes.
10. Quédate hasta que esté más calmada o llegue ayuda. Cuando te tengas que ir, dilo claro, despídete con respeto y, si puedes, dile a dónde puede pedir más ayuda.

QUÉ NO HACER

- NO la presiones a contar lo que vivió ni a 'desahogarse'.
- NO minimices lo que siente. Evita 'no fue nada', 'no llores', 'ya pasó', 'tienes que ser fuerte'.
- NO hagas promesas que no puedes cumplir ni des información falsa ('todo va a estar bien', 'voy a encontrar a tu familiar').
- NO la toques sin permiso (abrazo, mano en el hombro): pregunta antes.
- NO la dejes sola si dice que quiere hacerse daño: quédate con ella y busca ayuda de inmediato.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Tiene dolor en el pecho, le falta el aire o se desmaya: puede ser del corazón, no solo nervios.
- Tiene un ataque de pánico y los síntomas físicos (corazón acelerado, falta de aire) no ceden tras unos minutos: busca ayuda médica de inmediato.
- Dice que quiere hacerse daño o quitarse la vida: no la dejes sola y busca ayuda urgente.
- Se pone violenta y hay riesgo de que se lastime o lastime a otros.
- Días o semanas después la angustia sigue tan fuerte que no la deja dormir, comer ni hacer su vida: busca ayuda profesional de salud mental.

FUENTES OFICIALES:

OMS / WHO — Primeros auxilios psicológicos: guía para trabajadores de campo (2011)

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241548205>

IFRC · Centro de Referencia de Apoyo Psicosocial — Guía de Primeros Auxilios Psicológicos (Observar · Escuchar · Conectar)

<https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Guide-low-res.pdf>

OPS / OMS — Observar, escuchar y conectar: cuidado de la salud mental

<https://www.paho.org/es/noticias/12-6-2020-observar-escuchar-conectar-clave-para-cuidado-mutuo-salud-mental>

16 Reacción alérgica grave (anafilaxia): qué hacer

Emergencia mortal en minutos por una alergia severa. Usa esto cuando alguien, tras comer algo, una picadura o un medicamento, empieza a hincharse, le cuesta respirar o se desmaya.

PASOS

1. Reconoce las señales de alarma: hinchazón de cara, labios, lengua o garganta; ronchas o sarpullido con picazón; dificultad para respirar o tragar; silbidos al respirar (sibilancias); mareo o desmayo; vómito o diarrea; pulso débil y rápido; y a veces una fuerte sensación de que algo muy malo va a pasar.
2. Llama YA al 911 (o al número de emergencia local). Di claramente: 'es una reacción alérgica grave, anafilaxia, y puede necesitar epinefrina'. No esperes a ver si mejora sola.
3. Si la persona tiene un autoinyector de epinefrina (tipo EpiPen), ayúdala a usarlo de inmediato, antes de que empeore. Se aplica presionándolo con firmeza contra la parte de afuera, en el medio del muslo (puede ser por encima de la ropa). Mantenlo presionado unos segundos según las instrucciones del aparato.
4. Acuesta a la persona boca arriba y que se quede quieta; si puedes, levántale un poco las piernas. Esto ayuda a que no le baje la presión de golpe.
5. Si le cuesta mucho respirar, déjala sentarse en la posición que le sea más cómoda. Si está vomitando o sangra por la boca, ponla de lado para que no se ahogue.
6. Afloja la ropa apretada y cúbreala con una manta para mantenerla abrigada mientras llega la ayuda.
7. Si después de unos 5 minutos no mejora (y no antes), la ayuda médica aún no llega y hay un segundo autoinyector disponible, aplica una segunda dosis en el muslo.
8. Si la persona deja de respirar, no responde y no se mueve, empieza RCP (reanimación): compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho, de 100 a 120 por minuto, sin parar hasta que llegue la ayuda.
9. Aunque la persona mejore, debe ir al hospital igual: los síntomas pueden volver horas después.

QUÉ NO HACER

- No la hagas pararse ni caminar de golpe, ni la sientes bruscamente: el cambio brusco a estar de pie o sentada puede causar un paro y muerte súbita en la anafilaxia.
- No le des nada de beber ni medicinas por la boca si le cuesta respirar o tragar (riesgo de ahogo).
- No esperes 'a ver si se le pasa' para llamar al 911 ni para usar la epinefrina: cada minuto cuenta.
- No tengas miedo de usar el autoinyector de epinefrina en el muslo: es el tratamiento que salva la vida.
- No dejes sola a la persona; quédate vigilando su respiración hasta que llegue la ayuda.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 SIEMPRE ante una reacción alérgica grave: la anafilaxia puede matar en minutos.
- Llama de inmediato si hay hinchazón de cara, labios, lengua o garganta, dificultad para respirar o tragar, o silbidos al respirar.
- Llama si la persona se desmaya, se ve muy mareada, pálida o con pulso débil y rápido.
- Aunque ya hayas usado la epinefrina y mejore, igual debe ser vista por personal médico: los síntomas pueden regresar.

FUENTES OFICIALES:

Cruz Roja Americana (American Red Cross) — Allergic Reaction / Anaphylaxis: Causes, Symptoms, How To Help

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/allergic-reaction-anaphylaxis>

Mayo Clinic — Anaphylaxis: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-anaphylaxis/basics/art-20056608>

World Allergy Organization (WAO) — World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7607509/>

CCOHS (Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional) — First Aid - Using an Epinephrine Auto-injector

https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/firstaid/firstaid_epinephrine.html

17 Si alguien se tragó algo tóxico (químicos, limpieza, medicinas, plantas)

Qué hacer cuando una persona tragó un veneno o producto peligroso: aleja, averigua qué fue, llama a emergencias y sigue sus indicaciones; NUNCA hagas vomitar por tu cuenta.

PASOS

1. Aleja a la persona de lo que la intoxicó. Si fue un gas o humo (por ejemplo cloro mezclado), sácala al aire libre. Si quedó algo en la boca, retíralo con cuidado con los dedos.
2. Averigua qué tragó y cuánto, y desde hace cuánto tiempo. Guarda el envase, la botella, la caja o la planta para mostrárselos a quien te ayude: la etiqueta tiene información importante.
3. Llama de inmediato a emergencias o a un centro de toxicología. Ten a mano: el nombre del producto, cuánto se tragó, hace cuánto pasó, y la edad y el peso de la persona. (En EE. UU., la línea de ayuda por envenenamiento es 1-800-222-1222.)
4. Sigue al pie de la letra lo que te indiquen por teléfono. Ellos saben qué hacer según lo que tragó. No hagas nada por tu cuenta antes de escucharlos.
5. Si la persona está inconsciente pero respira, recuéstala de costado (de lado), con la cabeza un poco hacia abajo, para que no se ahogue si vomita. Quédate con ella y vigila que siga respirando.
6. Si la persona vomita por sí sola, voltéale la cabeza hacia un lado para que no se atragante. No la obligues a vomitar.
7. Si deja de respirar o no responde, llama al 911 y empieza RCP si sabes hacerlo, hasta que llegue la ayuda.

QUÉ NO HACER

- NO la hagas vomitar, salvo que un profesional te lo indique. Muchos químicos corrosivos (cloro, destapacaños, ácidos, limpiadores fuertes) queman de nuevo la garganta y el esófago al subir, y empeoran el daño.
- NO uses jarabe de ipecacuana ni ningún remedio para provocar el vómito. Ya no se recomienda.
- NO le des leche, agua, sal, ni 'remedios caseros' por tu cuenta. Dáselos solo si un profesional o el centro de toxicología te lo indica.
- NO le des nada por la boca si está inconsciente, con convulsiones o no puede tragar: se puede ahogar.
- NO intentes 'neutralizar' el veneno con vinagre, limón, bicarbonato u otra cosa.
- NO esperes a que aparezcan síntomas para pedir ayuda: llama de una vez.
- NO entres a un espacio cerrado lleno de gas o humo para rescatar sin protección: puedes intoxicarte tú también. Espera a los bomberos.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 si la persona está adormilada, no se despierta o está inconsciente.
- Llama al 911 si tiene dificultad para respirar o dejó de respirar.
- Llama al 911 si tiene convulsiones (ataques).
- Llama al 911 si está muy inquieta, agitada o desorientada.
- Llama al 911 si tragó algo a propósito o tomó una sobredosis de medicinas.
- Si no estás seguro de la gravedad, llama igual al centro de toxicología o a emergencias: la llamada es gratis y te orientan.

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Poisoning: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-poisoning/basics/art-20056657>

Poison Control (America's Poison Centers) — First Aid: Act Fast!

<https://www.poison.org/first-aid-for-poisonings>

American Red Cross — Poison Exposure: Signs, Symptoms, and First Aid

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/poison-exposure>

Poison Help (HRSA) — Calling Poison Help: What to have ready

<https://poisonhelp.hrsa.gov/faq/calling-poison-help>

Merck Manual (Consumer Version) — Caustic Chemicals Poisoning

<https://www.merckmanuals.com/home/injuries-and-poisoning/poisoning/caustic-chemicals-poisoning>

18 Mordedura de serpiente o picadura de alacrán (escorpión)

Toda mordedura de serpiente o picadura de alacrán es una emergencia: lleva a la persona al hospital de inmediato para el suero (antiveneno). Mantenla quieta y calmada mientras tanto.

PASOS

1. Aléjate de la serpiente o el alacrán. No trates de atraparlo ni de matarlo: pierdes tiempo y te puedes lastimar.
2. Mantén a la persona quieta, sentada o acostada, y muy calmada. Moverse hace que el veneno se reparta más rápido por el cuerpo.
3. Quítale anillos, reloj, pulseras y ropa apretada cerca de la zona mordida ANTES de que empiece a hincharse.
4. Deja la parte mordida quieta y a la altura del corazón o un poco más abajo. No dejes que la persona camine si no es absolutamente necesario.
5. Si puedes, lava la herida con agua y jabón y cúbreala sin apretar con un paño o vendaje limpio y seco.
6. Trata de recordar el color y la forma de la serpiente o el alacrán (solo si lo puedes ver sin acercarte). Eso ayuda al médico, pero NO lo persigas para mirarlo.
7. Lleva a la persona al hospital o centro de salud YA. El único tratamiento real es el suero (antiveneno) que se pone bajo supervisión médica. Mientras más rápido llegue, mejor.
8. Si la persona vomita, ponla de lado (sobre el lado izquierdo) para que no se ahogue. Vigila que siga respirando.

QUÉ NO HACER

- NO pongas torniquete ni amarres la zona para 'cortar la sangre'.
- NO cortes la herida con cuchillo ni navaja.
- NO chupes ni succiones el veneno con la boca ni con ningún aparato.
- NO pongas hielo sobre una mordedura de serpiente.
- NO le des alcohol ni bebidas con cafeína (café, energizantes).
- NO le des aspirina, ibuprofeno ni naproxeno: pueden aumentar el sangrado (puedes dar paracetamol para el dolor si el médico lo indica).
- NO uses remedios caseros, hierbas, rezos ni 'piedras negras': no sirven y hacen perder tiempo valioso.
- NO persigas ni trates de capturar a la serpiente o el alacrán para identificarlo: solo recuerda cómo era.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- SIEMPRE. Toda mordedura de serpiente se trata como emergencia: llama al 911 o ve al hospital de inmediato, aunque la persona se sienta bien al principio.
- Toda picadura de alacrán: busca atención médica de una vez, sin esperar a que aparezcan mareos, vómitos, sudoración o latidos rápidos (especialmente en niños).
- Llama al 911 urgente si hay: dificultad para respirar o tragar, babeo o saliva excesiva, hinchazón que crece rápido, dolor muy fuerte, vómitos, convulsiones, temblores, visión borrosa o si la persona se desmaya.
- Los niños corren más riesgo y se complican más rápido que los adultos: trasládalos sin perder tiempo.

FUENTES OFICIALES:

Organización Mundial de la Salud (OMS) — Snakebite envenoming

<https://www.who.int/health-topics/snakebite>

Mayo Clinic — Snakebites: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-snake-bites/basics/art-20056681>

American Red Cross (Cruz Roja Americana) — Snake Bites: Symptoms, Causes, and Treatment

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/venomous-snake-bites>

CDC / NIOSH — Insects and Scorpions at Work

<https://www.cdc.gov/niosh/outdoor-workers/about/insects-and-scorpions.html>

Universidad Central de Venezuela (UCV) - SOS Telemedicina — Escorpiones: ¿Qué hacer en caso de emponzoñamiento?

https://sosteledicina.ucv.ve/escorpio/escorpio.php?module=aspectos_des&id=10

19 Herida con un objeto clavado (no lo saques)

Qué hacer cuando algo quedó clavado en el cuerpo (cuchillo, varilla, vidrio, escombros): déjalo puesto, sujétalo para que no se mueva y llama al 911.

PASOS

1. NO saques el objeto. Aunque cause miedo verlo, déjalo donde está. Muchas veces el objeto está tapando una vena o arteria y, si lo sacas, la persona puede sangrar mucho más.
2. Llama YA al 911 (o al número de emergencia de tu zona). Pide ayuda de inmediato; este tipo de herida siempre necesita atención médica profesional.
3. Mantén a la persona lo más quieta posible y tranquilízala. Mientras menos se mueva, menos se mueve el objeto y menos daño hace.
4. Si la herida sangra, haz presión a los LADOS de la herida, alrededor del objeto, nunca encima de él. Usa una tela limpia o gasa doblada en cada lado.
5. Sujeta el objeto para que no se mueva: pon trapos o vendas enrollados alrededor del objeto, a ambos lados, como un soporte. Luego envuélvelos con una venda o tela para que el objeto quede firme y no se incline ni gire.
6. No vendas por encima del objeto ni lo aprietes. La venda solo debe sostener los trapos que están a los lados.
7. Cubre a la persona con una manta o ropa para que no pase frío y quédate con ella, hablándole con calma, hasta que llegue la ayuda.
8. Vigila a la persona: si se pone pálida, fría, con sudor frío, muy débil o confundida, avísalo al 911, porque puede ser señal de que está perdiendo mucha sangre.

QUÉ NO HACER

- No saques el objeto clavado por ningún motivo: eso lo debe hacer solo personal médico.
- No hagas presión encima del objeto; presiona solo a los lados, alrededor de la herida.
- No muevas ni jales el objeto, ni lo gires para 'acomodarlo'.
- No muevas de más a la persona ni la hagas caminar si no es necesario.
- No metas los dedos ni nada dentro de la herida para revisar.
- No le des de comer ni de beber, por si necesita cirugía.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 SIEMPRE que haya un objeto clavado en el cuerpo: es una emergencia.
- Llama de inmediato si la herida sangra mucho o el sangrado no se detiene aunque hagas presión a los lados.
- Llama si el objeto está clavado en la cabeza, cuello, pecho, abdomen o cerca de los ojos o los genitales.
- Llama si la persona se pone pálida, fría, sudorosa, muy débil, mareada o confundida (posible pérdida grave de sangre).
- Busca atención médica aunque la herida se vea pequeña: por dentro puede ser más profunda y puede infectarse.

FUENTES OFICIALES:

Cruz Roja Americana (American Red Cross) — Bleeding (Life-Threatening External)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/bleeding-life-threatening-external>

Mayo Clinic — Foreign object in the skin: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid/basics/art-20056604>

Mayo Clinic — Puncture wounds: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-puncture-wounds/basics/art-20056665>

St John Ambulance (St John Victoria) — How to provide first aid to a major wound

<https://www.stjohnvic.com.au/news/provide-first-aid-major-wound/>

Cleveland Clinic — Puncture Wound

<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/puncture-wound>

20 Golpe en la cabeza (posible conmoción cerebral)

Qué hacer ante un golpe en la cabeza y las señales de alarma que obligan a buscar ayuda de emergencia de inmediato.

PASOS

1. Si la persona se golpeó fuerte la cabeza, el cuello o la espalda (por ejemplo en un derrumbe) y NO puedes descartar lesión de cuello o columna: NO la muevas. Déjala en la posición en que la encontraste y mantén su cabeza quieta, salvo que esté en peligro inmediato (fuego, agua, derrumbe). No le muevas el cuello.
2. Mantén a la persona quieta y en reposo. Si está acostada, puede estar con la cabeza y los hombros un poco elevados. Que descanse y no siga moviéndose ni haciendo esfuerzos.
3. Si hay un chichón o hinchazón, ponle frío: una bolsa de hielo o algo frío envuelto en un paño limpio, NUNCA el hielo directo sobre la piel. Déjalo de 10 a 20 minutos cada vez. Puedes repetir cada pocas horas las primeras 24 a 48 horas.
4. Si hay una herida que sangra, presiona suave con un paño limpio o gasa. No presiones fuerte si sospechas que hay hundimiento o fractura del cráneo.
5. Vigila a la persona de cerca por lo menos durante las primeras 24 horas (mejor 24 a 48 horas). Quédate con ella y revísala seguido: que esté despierta, que responda, que respire bien y que se comporte normal. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después.
6. Que descanse el cuerpo y la mente esos primeros días: dormir bien, evitar esfuerzos físicos o mentales grandes, pantallas y ruido fuerte si la molestan.
7. Si en cualquier momento aparece UNA de las señales de alarma de la lista de abajo, busca atención de emergencia o llama al 911 de inmediato.

QUÉ NO HACER

- NO dejes sola a la persona durante las primeras horas: necesita que alguien la vigile por si empeora.
- NO le des bebidas alcohólicas ni drogas: pueden ocultar o empeorar las señales de una lesión grave.
- NO le des calmantes para el dolor por tu cuenta (como ciertos analgésicos): pueden tapar las señales de alarma. Que los indique un personal de salud.
- NO le muevas el cuello ni la cabeza si sospechas lesión de cuello o columna, ni la sacudas para 'despertarla'.
- NO pongas el hielo directo sobre la piel: siempre envuelto en un paño.
- NO ignores las señales de alarma ni esperes 'a ver si se le pasa'. Aunque la persona parezca estar bien al principio, puede empeorar después.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 o busca atención de emergencia de inmediato si después del golpe aparece cualquiera de estas señales:
- Pérdida del conocimiento (se desmayó o quedó inconsciente), aunque haya sido por poco tiempo.
- Vómitos repetidos (especialmente si vomita una y otra vez por más de 30 minutos).
- Confusión que aumenta, no reconoce a las personas o los lugares, o un comportamiento extraño, inquieto o agitado.
- Somnolencia anormal: muy dormido, cuesta despertarlo o no logra mantenerse despierto.
- Dolor de cabeza que empeora y no se le quita.
- Convulsiones o ataques (temblores o sacudidas del cuerpo).
- Una pupila más grande que la otra, o ve doble / cambios en la vista.

- Habla enredada (arrastra las palabras), debilidad, hormigueo o pérdida de coordinación o de equilibrio.
- Sale sangre o un líquido transparente por la nariz o los oídos.
- En un bebé o niño pequeño: llora sin parar y no se calma, o no quiere comer ni tomar pecho.

FUENTES OFICIALES:

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) — HEADS UP — Signs and Symptoms of Concussion (señales de peligro, incluye bebés y niños)

<https://www.cdc.gov/heads-up/signs-symptoms/index.html>

CDC — Traumatic Brain Injury & Concussion — Recovering from a Mild Traumatic Brain Injury or Concussion (reposo, vigilancia 24 h, señales de peligro)

https://www.cdc.gov/traumatic-brain-injury/media/pdfs/2024/05/patient_discharge_instructions_ENG-508.pdf

Mayo Clinic — Head trauma: First aid (mantener quieto, no mover el cuello, pupila desigual, líquido por nariz/oídos)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-head-trauma/basics/art-20056626>

American Red Cross (Cruz Roja Americana) — Concussion: Symptoms, Causes, and Treatment (reposo, llamar al 911, evitar analgésicos, vigilar a la persona)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/concussion>

Kaiser Permanente (guía de cuidado basada en consenso CDC) — Concussion (Mild Traumatic Brain Injury): Care Instructions (hielo 10–20 min con paño, no alcohol, vigilar 24 h)

<https://healthy.kaiserpermanente.org/health-wellness/health-encyclopedia/he.concussion-mild-traumatic-brain-injury-care-instructions.uf7532>

21 Sangrado de nariz (epistaxis)

Cómo detener un sangrado de nariz: siéntate, inclina la cabeza hacia adelante y aprieta la parte blanda de la nariz por 10 a 15 minutos sin soltar.

PASOS

1. Siéntate y mantén la calma. Inclina la cabeza un poco hacia ADELANTE (no hacia atrás). Así la sangre sale por la nariz y no baja por la garganta.
2. Con dos dedos (pulgar e índice) aprieta la parte blanda de la nariz, justo abajo del hueso. Aprieta las dos fosas juntas.
3. Mantén apretado de forma continua por 10 a 15 minutos. No sueltes para revisar, porque el sangrado puede empezar de nuevo. Si tienes reloj o celular, mide el tiempo.
4. Mientras aprietas, respira por la boca.
5. Puedes ponerte algo frío (una bolsa de hielo envuelta en un paño) sobre el puente de la nariz para ayudar a que el sangrado pare más rápido. Es opcional.
6. A los 10 a 15 minutos, suelta despacio y revisa. Si sigue sangrando, vuelve a apretar otros 10 a 15 minutos sin soltar.
7. Cuando pare, evita sonarte, tocarte o hurgarte la nariz por varias horas, y no levantes cosas pesadas, para que no vuelva a sangrar.

QUÉ NO HACER

- NO inclines la cabeza hacia atrás ni te acuestes boca arriba: la sangre baja por la garganta hasta el estómago y puede dar náuseas, vómito o atragantamiento.
- NO sueltes la nariz antes de tiempo solo para revisar; eso reinicia el sangrado.
- NO te suenes la nariz, no te hurgues ni te frotes la nariz mientras sangra ni en las horas siguientes.
- NO levantes peso ni hagas esfuerzo fuerte mientras o justo después del sangrado.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- El sangrado no para después de 20 a 30 minutos apretando bien.
- El sangrado es muy abundante o sientes que te tragas mucha sangre.
- El sangrado vino por un golpe fuerte o accidente y sospechas que la nariz está rota.
- La persona toma medicinas para adelgazar la sangre (anticoagulantes, como warfarina o aspirina en dosis altas).
- La persona se siente mareada, débil, a punto de desmayarse o tiene dificultad para respirar.

FUENTES OFICIALES:

Mayo Clinic — Nosebleeds: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-nosebleeds/basics/art-20056683>

Cleveland Clinic — 6 Steps To Stop a Nosebleed

<https://health.clevelandclinic.org/how-to-stop-a-nosebleed>

Cleveland Clinic — When To Worry About a Nosebleed: Is It Serious?

<https://health.clevelandclinic.org/do-you-get-too-many-nosebleeds-when-to-worry>

American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (AAO-HNS) — Clinical Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis)

<https://www.entnet.org/quality-practice/quality-products/clinical-practice-guidelines/nosebleed-epistaxis/>

American Red Cross — Nosebleed (Epistaxis)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/nosebleeds>

22 Inhalación de humo (incendio después del sismo)

Qué hacer cuando alguien respiró humo de un incendio: sácalo al aire fresco solo si es seguro, llama al 911 y vigila su respiración.

PASOS

1. Primero, tu seguridad. NO entres a un lugar lleno de humo ni a un edificio en llamas si te pones en peligro. Si arriesgas tu vida, espera a los bomberos o rescatistas.
2. Si es seguro hacerlo, saca a la persona del humo y llévala al aire fresco (afuera o a un lugar bien ventilado) lo más rápido posible.
3. Llama al 911 (o al número de emergencia local). Avisa que hubo humo de un incendio y describe cómo está respirando la persona.
4. Afloja la ropa apretada del cuello y el pecho para que pueda respirar mejor.
5. Mantén a la persona en reposo, sentada o recostada de lado (no boca arriba). Si vomita, gírale la cabeza hacia un lado para que no se ahogue.
6. Si la persona NO respira y no da señales de vida (no se mueve, no respira, no tose), empieza RCP de inmediato si sabes hacerlo, y sigue hasta que llegue ayuda.
7. Quédate con ella y vigila su respiración todo el tiempo. Los síntomas pueden aparecer o empeorar hasta 24 horas después, así que no la dejes sola.

QUÉ NO HACER

- NO entres a un lugar lleno de humo sin protección ni te metas a un incendio para rescatar a alguien si pones tu vida en peligro: espera a los rescatistas.
- NO subestimes los síntomas aunque la persona se sienta bien: pueden empeorar varias horas después (hasta 24 horas).
- NO acuestes boca arriba a alguien que vomita o está mareado; ponlo de lado.
- NO le des de comer ni de beber si tiene mucha dificultad para respirar o está confundida.
- NO esperes a que pase solo si hay quemaduras en la cara, hollín en boca o nariz, o dificultad para respirar: busca atención médica.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Llama al 911 SIEMPRE que la persona tenga dificultad para respirar, respiración ruidosa o ronquera.
- Llama al 911 si está confundida, muy somnolienta, mareada o pierde el conocimiento.
- Llama al 911 si tiene quemaduras en la cara, hollín en la boca o nariz, o vello de la nariz quemado (señal de quemadura en las vías respiratorias).
- Llama al 911 si no respira o no da señales de vida (empieza RCP de inmediato).
- Busca atención médica aunque la persona parezca estar bien si estuvo en un incendio o respiró mucho humo: los síntomas pueden tardar hasta 24 horas en aparecer.

FUENTES OFICIALES:

MedlinePlus (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) — Inhalation Injuries / Lesiones por inhalación
<https://medlineplus.gov/inhalationinjuries.html>

Manual MSD (versión para público general) — Inhalación de humo
<https://www.msdmanuals.com/es/hogar/traumatismos-y-envenenamientos/quemaduras/inhalaci%C3%B3n-de-humo>

Cleveland Clinic — Smoke Inhalation: Symptoms & When To Be Concerned
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/smoke-inhalation>

American Red Cross / Cruz Roja Americana — Smoke Inhalation (first aid guidance)
<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-pet-first-aid/dog/smoke-inhalation>

Salud y prevención

Cuidar la salud y evitar enfermedades tras el desastre: rehidratación, heridas, higiene y mosquitos.

23 **Diarrea y deshidratación: cómo hacer y dar suero oral en casa**

Tras un desastre, el agua sucia causa diarrea y deshidratación, que puede matar (sobre todo a bebés y niños). Usa este suero para reponer líquidos.

PASOS

1. Reconoce las señales de deshidratación: mucha sed, boca y lengua secas, orina poca y oscura, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, cansancio o irritabilidad. En bebés también: la mollera (parte blanda de la cabeza) se ve hundida.
2. Consigue 1 litro (1.000 ml) de AGUA SEGURA: agua embotellada, hervida y dejada enfriar, o agua tratada/clorada. Si no estás seguro, primero potabilízala. Lávate las manos antes de preparar.
3. Prepara el suero oral con la receta de la OMS: en 1 litro de agua segura disuelve 6 cucharaditas rasas de azúcar y media (½) cucharadita rasa de sal. Mezcla bien hasta que se disuelva. Pruébalo: no debe quedar más salado que las lágrimas.
4. Si tienes sobres de SRO/SRO (sales de rehidratación oral) de farmacia o de una organización de ayuda, úsalos en vez del casero: disuelve el sobre en la cantidad de agua segura que indique el paquete. Es la mejor opción.
5. Da el suero a sorbos pequeños y seguidos, con cucharita, taza o jeringa (sin aguja). Poquito y constante es mejor que mucho de golpe.
6. Da una cantidad extra después de CADA evacuación líquida (cada vez que va al baño con diarrea): a un niño menor de 2 años, entre 50 y 100 ml (de un cuarto a media taza); a un niño de 2 años o más, entre 100 y 200 ml (media a una taza). Un adulto debe tomar bastante, según la sed.
7. Si la persona vomita, espera unos 10 minutos y vuelve a dar el suero, pero más despacio y a sorbos más pequeños. Casi siempre logra retener algo.
8. Sigue dando de comer. Si es bebé, sigue amamantando todas las veces que pida; el pecho ayuda a recuperarse. A niños mayores y adultos, ofréceles comida en porciones pequeñas y frecuentes apenas la acepten.
9. Si tienes acceso a zinc para niños (jarabe o tabletas, viene en kits de ayuda), darlo junto con el suero ayuda a que la diarrea dure menos. Sigue la dosis del envase o del personal de salud.
10. Prepara suero nuevo cada día. Tira el que sobre después de 24 horas y haz uno fresco, porque se puede contaminar.
11. Sigue dando líquidos extra hasta que la diarrea se detenga. La meta es que orine claro y con normalidad.

QUÉ NO HACER

- NO uses gaseosas, jugos azucarados, bebidas energéticas ni bebidas deportivas como suero: tienen demasiada azúcar y pueden EMPEORAR la diarrea.
- NO des solo agua sola en grandes cantidades para tratar la deshidratación: no repone la sal que el cuerpo pierde.
- NO le des líquidos por la boca a alguien inconsciente, muy somnoliento o que no puede tragar: puede ahogarse. Busca ayuda urgente.
- NO insistas en dar más suero si la persona vomita TODO lo que toma y no retiene nada: necesita atención médica.
- NO te pases de sal: un suero muy salado es peligroso, sobre todo para bebés. Respeta media (½) cucharadita por litro.
- NO uses agua que no sea segura para preparar el suero; primero hiévela o trátala.
- NO des medicamentos para 'cortar' la diarrea (antidiarreicos) si hay fiebre alta o sangre en las heces: pueden empeorar la enfermedad.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Señales de deshidratación grave: muy somnoliento o inconsciente, no puede beber o bebe muy mal, ojos muy hundidos, o al pellizcar suavemente la piel esta tarda más de 2 segundos en volver a su lugar.
- Sangre en las heces (popó con sangre) o vómito con sangre.
- No logra retener ningún líquido (vomita todo) o sigue con diarrea muy abundante y frecuente.
- No orina en 8 horas o más (en bebés, pañal seco mucho tiempo o mollera muy hundida).
- Bebé pequeño, persona mayor o persona con otra enfermedad con diarrea: busca atención médica antes, porque se deshidratan más rápido.
- Fiebre alta, convulsiones, confusión o mareo fuerte al ponerse de pie. Llama al 911 o ve al centro de salud o refugio médico más cercano de inmediato.

FUENTES OFICIALES:

Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) — Cholera outbreaks – Q&A (receta de suero oral casero: 1 litro de agua segura, 6 cucharaditas de azúcar y media cucharadita de sal)

<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cholera-outbreaks>

OMS / Humanitarian Health Care Manual (NCBI Bookshelf) — Diarrhoea and dehydration – señales de deshidratación, cantidades de suero tras cada evacuación y qué hacer si vomita

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143745/>

UNICEF Supply Division — Oral rehydration salts (ORS) and zinc – uso de SRO y zinc en diarrea infantil

<https://www.unicef.org/supply/oral-rehydration-salts-ors-and-zinc>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE.UU.) — Cholera – Signs and Symptoms (señales de deshidratación grave y cuándo buscar atención)

<https://www.cdc.gov/cholera/signs-symptoms/index.html>

OMS / UNICEF — WHO/UNICEF Joint Statement: Clinical Management of Acute Diarrhoea (SRO de baja osmolaridad + zinc, seguir alimentando)

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/07/WHO-UNICEF_Joint-Statement_clinical-management-of-acute-diarrhoea.pdf

24 Cómo cuidar heridas y cortes para evitar infección y tétanos

Limpiar y cubrir bien cualquier corte o herida tras el terremoto, para evitar que se infecte o dé tétanos; clave porque los escombros y el agua sucia traen muchos microbios.

PASOS

1. Lávate bien las manos con agua limpia y jabón antes de tocar la herida. Si puedes, ponte guantes y no toques la herida con los dedos.
2. Detén el sangrado: presiona la herida con una tela o gasa limpia hasta que pare. Si sangra mucho y no para, busca ayuda médica.
3. Lava la herida echándole agua limpia o agua embotellada a chorro, para arrastrar la suciedad. Lava **ALREDEDOR** de la herida con agua limpia y jabón.
4. Quita con cuidado la suciedad o tierra que veas. Si hay un objeto clavado (vidrio, madera, metal) o no sale la mugre, **NO** escarbes: busca atención médica.
5. Seca con toques suaves usando una tela o gasa limpia. No frotes fuerte.
6. Cubre la herida con una gasa o tela limpia y seca. Si vas a estar cerca de agua sucia o de inundación, usa una venda a prueba de agua.
7. Cambia el vendaje todos los días, y también cada vez que se moje o se ensucie. Antes de tocar la herida, lávate las manos otra vez.
8. Mantén la herida limpia y seca. Revísala a diario buscando señales de infección.
9. Vacuna contra el tétanos: si la herida es sucia, profunda o punzante (por ejemplo, pisar un clavo, metal oxidado, mordida, escombros) y tu última vacuna fue hace 5 años o más (o no sabes/nunca te vacunaste), busca un refuerzo lo antes posible. En heridas limpias, el refuerzo se recomienda si pasaron 10 años o más.
10. **SEÑALES DE INFECCIÓN** (vigílaslas): enrojecimiento que crece alrededor de la herida; calor en la zona; hinchazón; dolor que aumenta; pus o líquido turbio; mal olor; fiebre; y líneas rojas que salen de la herida hacia el resto del cuerpo. Si aparece cualquiera, busca atención médica.

QUÉ NO HACER

- **NO** laves la herida con agua de inundación, charcos, ríos ni agua sucia: trae microbios y puede infectarla. Usa agua limpia o embotellada.
- **NO** eches alcohol, agua oxigenada (peróxido) ni yodo **DENTRO** de la herida: irrita y daña la piel. Limpia por dentro solo con agua limpia.
- **NO** entres al agua de inundación si tienes una herida abierta; si no hay más remedio, cúbreala con una venda a prueba de agua y, si puedes, usa botas y guantes de goma.
- **NO** toques la herida con las manos sucias ni con los dedos sin lavar.
- **NO** saques tú mismo un objeto clavado (vidrio, metal, madera): puede sangrar más; déjalo y busca ayuda médica.
- **NO** ignores las señales de infección ni esperes a que empeore para buscar ayuda.
- **NO** dejes la herida destapada y sucia: cúbrela y mantenla limpia y seca.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Busca atención médica de inmediato si la herida tiene enrojecimiento que crece, hinchazón, calor, pus, mal olor, dolor que aumenta, fiebre o líneas rojas que salen hacia el cuerpo (puede ser infección que se está esparciendo).
- Busca ayuda médica si la herida es profunda, muy sucia, punzante (como pisar un clavo) o tiene tierra, escombros, heces o saliva.
- Busca ayuda médica si es una mordida de animal o persona.

- Busca un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si la herida es sucia/punzante y tu última vacuna fue hace 5 años o más, no sabes cuándo fue, o nunca te vacunaste.
- Busca ayuda si hay un objeto clavado en la herida o si no logras quitar la suciedad.
- Llama al 911 o ve a urgencias si el sangrado es fuerte y no para con presión, la herida es muy grande o profunda, o tienes fiebre alta con escalofríos y te sientes muy mal.

FUENTES OFICIALES:

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.) — Emergency Wound Care After a Natural Disaster (Cuidado de heridas de emergencia después de un desastre natural)

<https://www.cdc.gov/natural-disasters/communication-resources/emergency-wound-care-after-a-natural-disaster-factsheet.html>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.) — Safety Guidelines: Floodwater (Heridas abiertas y agua de inundación)

<https://www.cdc.gov/floods/safety/floodwater-after-a-disaster-or-emergency-safety.html>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.) — About Tetanus / Clinical Guidance for Wound Management to Prevent Tetanus (Tétanos: heridas de riesgo y vacuna)

<https://www.cdc.gov/tetanus/hcp/clinical-guidance/index.html>

Mayo Clinic — Cuts and scrapes: First aid (Cortes y raspones: primeros auxilios)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cuts/basics/art-20056711>

OMS (Organización Mundial de la Salud) — Prevention and management of wound infection (Prevención y manejo de la infección de heridas)

<https://www.who.int/publications/i/item/prevention-and-management-of-wound-infection>

25 Higiene y prevención de enfermedades en un refugio o tras el desastre

Pasos sencillos para evitar diarrea y otras enfermedades cuando hay muchas personas juntas: lavarse las manos, beber agua segura, manejar bien la basura y las heces, y cuidar la comida.

PASOS

1. Lávate las manos con agua y jabón en los momentos clave: antes de comer, antes de cocinar o tocar comida, después de ir al baño, después de cambiar a un niño y después de atender a un enfermo. Frota durante al menos 20 segundos (cuenta despacio hasta 20) y enjuaga.
2. Si no hay jabón, lávate las manos frotando con ceniza limpia (de madera quemada) o arena y bastante agua. Es mejor que solo agua. El jabón sigue siendo lo ideal: úsalo apenas tengas.
3. Bebe y cocina SOLO con agua segura. Si no estás seguro de que el agua es segura, trátala así: hiérvela 1 minuto a borbotones y déjala enfriar; o ponla en una botella de plástico transparente y limpia, acostada al sol 6 horas en día soleado (2 días seguidos si está nublado). Si el agua está turbia, primero déjala reposar o cuélala con tela limpia antes de tratarla.
4. Maneja la basura y las heces LEJOS del agua y de la comida. La letrina o el pozo deben estar al menos a 30 metros de cualquier fuente de agua (pozo, río, tanque) y, si hay pendiente, más abajo que el agua. Tapa la basura y las heces.
5. Cubre y protege los alimentos: tápalos para que no les caigan moscas ni polvo, lava frutas y verduras con agua segura, cocina bien la carne, el pollo, el huevo y el pescado, y separa la comida cruda de la cocida.
6. No dejes la comida cocinada más de 2 horas a temperatura ambiente; si pasó ese tiempo y hace calor, es más seguro no comerla. Sirve la comida bien caliente.
7. Si puedes, separa a las personas enfermas (con diarrea o vómito) en una zona aparte y que usen su propio baño, vaso, plato y toalla.
8. Si alguien tiene diarrea, dale líquidos para que no se deshidrate. Suero oral casero: 1 litro de agua segura + 6 cucharaditas rasas de azúcar + media (1/2) cucharadita de sal. Mezcla bien y dale a sorbos seguido. Prepara una jarra nueva cada día: bota lo que sobre después de 24 horas.

QUÉ NO HACER

- No defeques ni botes aguas sucias cerca del agua, los pozos o la comida.
- No tomes agua sin tratar (de río, charco o de fuente dudosa) aunque se vea limpia.
- No compartas vasos, platos, cubiertos ni toallas con personas enfermas.
- No prepares ni toques comida para otros si tienes diarrea o vómito.
- No uses solo agua para 'lavarte' las manos si tienes jabón o ceniza disponible: el agua sola limpia menos.
- No guardes el suero oral casero de un día para otro: bóvalo a las 24 horas y prepara nuevo.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Si en el refugio aparecen VARIAS personas con diarrea o vómito al mismo tiempo: puede ser un brote. Avisa de inmediato al personal de salud o al coordinador del refugio.
- Busca atención médica urgente si la persona con diarrea tiene señales de deshidratación: mucha sed, boca y lengua secas, orina poca o muy oscura, ojos hundidos, debilidad o mareo al pararse.
- Llama al 911 o ve a un centro de salud YA si hay diarrea muy líquida y abundante (como agua de arroz), vómitos que no paran, no logra tomar líquidos, está muy decaído, confundido o no responde bien: la deshidratación grave puede ser mortal en pocas horas.
- En bebés y niños pequeños, ancianos o personas enfermas, busca ayuda antes: se deshidratan más rápido. Señales en bebés: no moja pañales, llora sin lágrimas, está muy flojo o tiene la mollera hundida.

FUENTES OFICIALES:

OMS / WHO — Cholera (fact sheet): WASH, lavado de manos con jabón, agua y alimentos seguros, disposición segura de heces, y atención urgente ante diarrea acuosa grave

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera>

OMS / WHO — Five keys to safer food (Cinco claves para la inocuidad de los alimentos)

<https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling/five-key-to-safer-food>

OPS / PAHO — PAHO/WHO recommends five keys to safer food (separar crudo/cocido, cocer bien, no dejar comida >2h, agua segura)

<https://www.paho.org/en/news/21-12-2015-pahowho-recommends-five-keys-safer-food-healthy-holiday-season>

CDC — Global Hygiene (lavado de manos con jabón al menos 20 segundos; momentos clave)

<https://www.cdc.gov/global-water-sanitation-hygiene/about/about-global-hygiene.html>

CDC — Water Disinfection for Travelers (hervir 1 minuto; SODIS: botella transparente, 6 horas al sol o 2 días si está nublado; aclarar agua turbia primero)

<https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/preparing-international-travelers/water-disinfection-for-travelers.html>

CDC — How to make oral rehydration solution (ORS): 1 litro de agua, 6 cucharaditas rasas de azúcar, 1/2 cucharadita de sal

https://www.cdc.gov/global-water-sanitation-hygiene/media/pdfs/ors_seasia_508.pdf

Sphere / Emergency WASH (basado en OMS) — Minimum standards in Water Supply, Sanitation and Hygiene: letrinas a ≥ 30 m de fuentes de agua

<https://handbook.spherestandards.org/>

26 Prevención de enfermedades por mosquitos (dengue, malaria, zika, chikungunya) después del terremoto

Cómo evitar las picaduras de mosquitos y eliminar el agua estancada para prevenir dengue y otras enfermedades; úsalo en casa, refugios y zonas afectadas donde se junta agua.

PASOS

1. Elimina el agua estancada cada semana. Los mosquitos del dengue ponen huevos en agua quieta. Vacía, voltea, tapa o bota todo lo que junte agua: baldes, tobos, botellas, latas, floreros, llantas (cauchos), tapas, juguetes y recipientes viejos.
2. Tapa bien los tanques, pipas y depósitos de agua. Mantén siempre cubiertos los tanques y reservorios donde guardas agua, para que los mosquitos no entren a poner huevos.
3. Lava y restriega los recipientes de agua una vez por semana. Cepilla las paredes por dentro (no solo vacíos), porque los huevos quedan pegados; luego tápalos.
4. Recoge y bota la basura. No dejes que se acumule basura ni envases que junten agua; guarda la basura en bolsas plásticas cerradas.
5. Usa repelente contra mosquitos en la piel y la ropa que queda destapada. Sirven los que tienen DEET, picaridina (picaridin) o IR3535. Úsalo siguiendo las instrucciones del envase; estos repelentes registrados se consideran seguros incluso en embarazadas y mujeres que dan pecho cuando se usan como indica la etiqueta.
6. Ponte ropa que cubra la mayor parte del cuerpo: camisas o franelas de manga larga y pantalones largos, sobre todo al amanecer y al atardecer.
7. Duerme bajo mosquitero, sobre todo bebés, niños y mujeres embarazadas, y cuando no hay aire acondicionado ni ventanas con malla. Cubre también las cunas y los coches (sillas) de bebé con malla mosquitera.
8. Pon mallas (telas metálicas) en ventanas y puertas, y repara los huecos para que no entren mosquitos. Si puedes, quédate en lugares con ventanas y puertas con malla o con aire acondicionado.
9. Vigila las señales del dengue. La fiebre suele venir con dolor de cabeza fuerte, dolor detrás de los ojos, dolor de músculos y articulaciones (huesos) y a veces salpullido (ronchas). Descansa y toma muchos líquidos: agua o suero con electrolitos.
10. ATENCIÓN: las señales de dengue grave aparecen muchas veces 1 a 2 días DESPUÉS de que baja la fiebre, y empeoran en pocas horas. Busca atención médica de inmediato si aparecen estos signos de alarma (ver más abajo).

QUÉ NO HACER

- NO dejes recipientes ni tanques de agua destapados: son el criadero principal de los mosquitos del dengue.
- NO tomes ni le des a nadie aspirina ni ibuprofeno si sospechas dengue. La CDC y la OMS indican usar acetaminofén (paracetamol) para la fiebre y el dolor, y EVITAR aspirina e ibuprofeno y otros antiinflamatorios (AINEs) porque aumentan el riesgo de sangrado.
- NO te automediques con antibióticos ni inyecciones por tu cuenta para el dengue.
- NO ignores el dolor de barriga fuerte, el vómito que no para o el sangrado: son emergencia, no esperes a ver si pasa.
- NO confíes en que ya estás mejor solo porque bajó la fiebre: justo en esos 1 a 2 días pueden empezar las complicaciones graves.
- NO uses repelente con DEET en bebés menores de 2 meses; para ellos usa mosquitero sobre la cuna o el coche.
- NO acumules basura ni dejes agua sucia juntándose alrededor de la casa o el refugio.

CUÁNDO LLAMAR AL 911

- Busca atención médica urgente (o llama a emergencias) si después de la fiebre aparece dolor fuerte o sensibilidad en la barriga (abdomen).
- Vómito persistente: al menos 3 veces en 24 horas.
- Sangrado por las encías o la nariz, sangre en el vómito o sangre en las heces (popó).
- Mucho sueño, cansancio extremo, persona inquieta o irritable, o cambios en la conciencia.
- Respiración rápida o dificultad para respirar, piel pálida y fría, mucha sed o debilidad fuerte.
- El dengue grave es una emergencia médica y empeora en pocas horas: si ves cualquiera de estas señales, busca ayuda de inmediato.

FUENTES OFICIALES:

OPS/OMS (PAHO) — Dengue: síntomas, prevención y tratamiento (Dengue topic page)

<https://www.paho.org/en/topics/dengue>

OPS/OMS (PAHO) — Vector Control in Disaster Situations

<https://www.paho.org/en/health-emergencies/vector-control-disaster-situations>

OMS (WHO) — Dengue and severe dengue – Fact sheet

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

CDC — Preventing Dengue

<https://www.cdc.gov/dengue/prevention/index.html>

CDC — Manage Dengue (treatment: usar acetaminofén, no aspirina ni ibuprofeno)

<https://www.cdc.gov/dengue/treatment/index.html>

CDC — Severe Dengue: Know the Warning Signs

<https://www.cdc.gov/dengue/stories/severe-dengue.html>

CDC — Preventing Mosquito Bites (repelente, ropa, mallas, mosquiteros)

<https://www.cdc.gov/mosquitoes/prevention/index.html>

Sismo y supervivencia

Qué hacer durante y después de un temblor, y cómo conseguir agua y comida seguras.

27 Durante el sismo: si estás dentro de un edificio

Agáchate, cúbrete y agárrate.

PASOS

1. AGÁCHATE: bájate de inmediato al piso, sobre manos y rodillas, antes de que el sismo te tumbe.
2. CÚBRETE: métete debajo de una mesa o escritorio resistente. Si no hay un mueble cerca, agáchate junto a una pared interior (no una con ventanas) y cubre tu cabeza y cuello con tus brazos.
3. AGÁRRATE: sostén la pata de la mesa con una mano y quédate ahí hasta que pare de temblar. Si la mesa se mueve, muévete con ella.
4. Si estás en la cama, quédate ahí, encógete y protege tu cabeza con una almohada.

QUÉ NO HACER

- NO corras hacia afuera durante el temblor: la mayoría de las lesiones son por objetos que caen o vuelan (lámparas, vidrios, estantes), no por el colapso del edificio.
- NO te pares en el marco de una puerta: es un mito, no te protege de objetos que vuelan.
- NO uses ascensores.
- NO te pongas junto a ventanas, espejos, vidrios ni objetos colgantes.

FUENTES OFICIALES:

Great ShakeOut · Earthquake Country Alliance — Agáchese, Cúbrase y Agárrase (Drop, Cover, Hold On)

<https://www.shakeout.org/dropcoverholdon/>

Protección Civil Venezuela · FUNVISIS — Guía de tres fases: qué hacer antes, durante y después de un sismo

<https://www.mpprijp.gob.ve/prensa/reporte/conozca-la-guia-de-tres-fases-sobre-que-hacer-antes-durante-y-despues-de-un-sismo>

28 Durante el sismo: si estás afuera o manejando

PASOS

1. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes de luz y cables eléctricos.
2. Ve a un área despejada y agáchate ahí hasta que pare el temblor.
3. Si vas manejando, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos elevados y edificios.
4. Quédate dentro del vehículo, con el cinturón puesto, hasta que pare el temblor.

QUÉ NO HACER

- NO te detengas debajo o encima de puentes, pasos elevados, ni junto a edificios o postes.
- NO te quedes cerca de cables eléctricos caídos.

FUENTES OFICIALES:

Protección Civil Venezuela · FUNVISIS — Guía de tres fases: qué hacer antes, durante y después de un sismo

<https://www.mpprijp.gob.ve/prensa/reporte/conozca-la-guia-de-tres-fases-sobre-que-hacer-antes-durante-y-despues-de-un-sismo>

Great ShakeOut · Earthquake Country Alliance — Agáchese, Cúbrase y Agárrase (Drop, Cover, Hold On)

<https://www.shakeout.org/dropcoverholdon/>

29 Después del sismo: réplicas, gas y evacuación

Lo primero tras el temblor: réplicas y fugas de gas.

PASOS

1. Espera réplicas: son sismos más pequeños que siguen al principal. Vuelve a "agáchate, cúbrete y agárrate" cada vez que tiemble.
2. Revisa si estás herido. Si puedes, ayuda a otros. No muevas a heridos graves a menos que estén en peligro inmediato.
3. Si hueles gas o ves una tubería rota, cierra la válvula principal desde afuera, abre una ventana y sal del lugar.
4. Si tu edificio está dañado, evacúa con calma usando las escaleras, nunca el ascensor.
5. No vuelvas a entrar a un edificio dañado hasta que las autoridades digan que es seguro. Sal si escuchas crujidos o ruidos extraños.
6. Usa el teléfono solo para emergencias; prefiere mensajes de texto. Sintoniza una radio confiable para instrucciones oficiales.

QUÉ NO HACER

- NO uses fósforos, encendedores, velas, electrodomésticos ni interruptores de luz hasta estar seguro de que no hay fuga de gas: una chispa puede causar una explosión.
- NO entres a edificios dañados.
- NO uses ascensores.

FUENTES OFICIALES:

CDC (EE.UU.) — Mantente seguro después de un terremoto (2024)

<https://www.cdc.gov/earthquakes/safety/stay-safe-after-an-earthquake.html>

Protección Civil Venezuela · FUNVISIS — Guía de tres fases: qué hacer antes, durante y después de un sismo

<https://www.mppriip.gob.ve/prensa/reporte/conozca-la-guia-de-tres-fases-sobre-que-hacer-antes-durante-y-despues-de-un-sismo>

30 Si quedas atrapado bajo escombros

Cómo lograr que te encuentren sin agotarte.

PASOS

1. Cúbrete la boca, la nariz y los ojos con una tela o tu camisa para protegerte del polvo.
2. Para que te encuentren, golpea con algo duro una tubería o una pared, o usa un silbato. Hazlo en grupos (por ejemplo, golpear fuerte 3 veces) cada pocos minutos: los rescatistas escuchan esos sonidos.
3. Si tienes teléfono, envía un mensaje de texto pidiendo ayuda (usa menos batería y red que una llamada).
4. Conserva tu energía y mantén la calma mientras esperas.

QUÉ NO HACER

- NO grites, salvo como último recurso: gritar te agota y puede hacerte inhalar polvo peligroso.
- NO enciendas fósforos ni encendedores: puede haber fuga de gas.
- NO te muevas más de lo necesario ni levantes polvo.

FUENTES OFICIALES:

CDC (EE.UU.) — Mantente seguro después de un terremoto (2024)

<https://www.cdc.gov/earthquakes/safety/stay-safe-after-an-earthquake.html>

Cruz Roja Americana — Seguridad en terremotos

<https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/earthquake.html>

31 Agua segura para beber: hervir

La forma más segura de potabilizar agua.

PASOS

1. Si el agua está turbia, primero déjala reposar para que el sedimento baje, o fíltrala con un paño limpio.
2. Pon el agua a hervir y mantenla en hervor fuerte (burbujeo intenso) durante 1 minuto. En casi toda Venezuela (incluida Caracas) basta con 1 minuto.
3. Solo en zonas de alta montaña (por encima de ~2.000 metros) hierve durante 3 minutos.
4. Deja enfriar sola, tapada. Guárdala en recipientes limpios con tapa.

QUÉ NO HACER

- Hervir NO elimina contaminación química ni combustible, solo microbios: no confíes en hervir agua con químicos tóxicos.
- No uses el agua mientras esté hirviendo (riesgo de quemadura); espera a que enfríe.

FUENTES OFICIALES:

CDC (EE.UU.) — Cómo hacer que el agua sea segura en una emergencia

<https://www.cdc.gov/water-emergency/about/index.html>

US EPA — Desinfección de emergencia del agua potable

<https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/emergency-disinfection-drinking-water>

32 Agua segura para beber: desinfectar con cloro

Si no puedes hervir, usa cloro doméstico sin perfume.

PASOS

1. Usa solo cloro (lejía) doméstico SIN perfume y sin aditivos (concentración de hipoclorito de sodio entre 5% y 9%, lo común en botellas de cloro).
2. Si el agua está turbia, fíltrala primero con un paño limpio y déjala asentar.
3. Para agua clara: agrega 2 gotas de cloro por cada 1 litro de agua (equivale a 8 gotas por galón / ~3,8 litros).
4. Si el agua está turbia o muy fría, usa el DOBLE: 4 gotas por litro.
5. Revuelve bien y deja reposar al menos 30 minutos antes de beber.
6. El agua debe tener un ligero olor a cloro. Si NO huele a cloro, repite la dosis y espera otros 15 minutos antes de usarla.

QUÉ NO HACER

- No uses cloro perfumado, en gel, "color-safe", ni con detergente añadido.
- No uses más cloro del indicado pensando que es "más seguro": el exceso de cloro es dañino.
- No confíes en el cloro para agua con contaminación química.

FUENTES OFICIALES:

CDC (EE.UU.) — Cómo hacer que el agua sea segura en una emergencia

<https://www.cdc.gov/water-emergency/about/index.html>

OMS / WHO — Métodos de tratamiento del agua y su desempeño

<https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/water-safety-and-quality/drinking-water-quality-guidelines>

33 Comida segura tras corte de luz o inundación

Qué guardar y qué botar cuando se va la luz.

PASOS

1. Mantén las puertas de la nevera y el congelador CERRADAS. La nevera mantiene la comida fría unas 4 horas sin luz. Un congelador lleno aguanta cerca de 48 horas (24 horas si está medio lleno) si no se abre.
2. Bota cualquier comida perecedera (carne, pollo, pescado, huevos, sobras, leche) que haya estado más de 4 horas por encima de 4 °C.
3. La comida congelada se puede volver a congelar con seguridad solo si todavía tiene cristales de hielo o está a 4 °C o menos.
4. Bota toda comida (incluso enlatada) que haya tocado agua de inundación.
5. Cuando tengas duda, bótala.

QUÉ NO HACER

- No pruebes la comida para "ver si está buena": puedes enfermarte aunque se vea y huela normal.
- No consumas latas abolladas, hinchadas, oxidadas o que tocaron agua de inundación.
- No vuelvas a congelar comida que ya pasó de 4 °C sin cristales de hielo.

FUENTES OFICIALES:

FoodSafety.gov (HHS, EE.UU.) — Seguridad de los alimentos durante un corte de luz
<https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage>

CDC (EE.UU.) — Mantén los alimentos seguros tras un desastre o emergencia
<https://www.cdc.gov/food-safety/foods/keep-food-safe-after-emergency.html>

34 Kit básico de emergencia

Lo esencial que conviene tener listo.

PASOS

1. Agua: ~3,8 litros (1 galón) por persona por día, para al menos 3 días (beber e higiene).
2. Comida no perecedera para al menos 3 días + abrelatas manual.
3. Radio a pilas o de manivela.
4. Linterna + pilas extra.
5. Botiquín de primeros auxilios.
6. Silbato (para pedir ayuda sin gastar la voz).
7. Mascarilla antipolvo; plástico y cinta adhesiva (teipe) para improvisar refugio.
8. Toallitas húmedas, bolsas de basura y amarres plásticos (higiene).
9. Llave inglesa o alicate para cerrar el gas y el agua.
10. Documentos importantes, medicinas personales, y necesidades de bebés o mascotas.
11. Teléfono con cargador y batería de respaldo. Guarda todo en uno o dos recipientes fáciles de cargar.

QUÉ NO HACER

- No dependas solo del celular para luz o información: ten linterna y radio físicos.
- No guardes el kit en un solo lugar inaccesible: ten uno en casa, el trabajo y el carro.

FUENTE OFICIAL:

Ready.gov / FEMA (EE.UU.) — Arma tu kit de emergencia (Build A Kit)
<https://www.ready.gov/kit>

Contactos de emergencia

Ante cualquier emergencia, llama primero al **911**. Solo los contactos verificados muestran número marcable; un número errado cuesta vidas.

VERIFICADOS

Emergencias 911

Llamar al 911: 911

Todo el país

Línea única de emergencia (bomberos, policía, ambulancia). Gratuita desde fijo y celular. Reemplazó al antiguo 171.

Cruz Roja Internacional (CICR) — Personas desaparecidas · personas desaparecidas

Llamar 0412-636.50.15: +584126365015 · Llamar 0424-172.13.64: +584241721364

Nacional

Servicio "Sigamos en Contacto": ayuda a buscar familiares desaparecidos y restablecer el contacto. Email: centrocontactove@icrc.org

Cruz Roja Venezolana — Sede Nacional

Llamar 0212-571.43.80: +582125714380

San Bernardino, Caracas

Sede nacional (Hospital Carlos J. Bello). No es una línea 24 h tipo 911.

Bomberos del Distrito Capital (Caracas)

Llamar 0212-545.45.45: +582125454545

Caracas / Distrito Capital

Para emergencia general en cualquier ciudad, marca 911. No hay un número nacional único de bomberos.

SIN VERIFICAR (NO LLAMAR A CIEGAS — USA EL 911)

Protección Civil (Dirección Nacional) — 0800-724.84.51 (sin verificar)

Nacional · Sede: Bello Monte, Caracas

Para una emergencia, marca 911 (canal confirmado). El 0800 está pendiente de verificación oficial.

FUNVISIS — Información sísmica — 0212-257.51.53 (sin verificar)

El Llanito, Caracas

Información sísmica y científica, NO es línea de emergencia médica. Para emergencias, marca 911.

Hospital Universitario de Caracas (HUC)

Los Chaguaramos, Municipio Libertador

Acude directo a Emergencia o marca 911. Teléfono no verificado oficialmente.

Hospital Dr. Domingo Luciani

El Llanito (límite con Petare)

Acude directo a Emergencia o marca 911. Teléfono no verificado oficialmente.

Hospital de Niños J.M. de los Ríos

San Bernardino, Caracas

Acude directo a Emergencia o marca 911. Teléfono no verificado oficialmente.

Hospital José María Vargas de Caracas

Centro de Caracas (San José)

Acude directo a Emergencia o marca 911. Teléfono no verificado oficialmente.

Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo

San Martín, Municipio Libertador

Acude directo a Emergencia o marca 911. Teléfono no verificado oficialmente.

Hospital Gral. del Oeste J. G. Hernández (Catia)

Los Magallanes de Catia, oeste de Caracas

Acude directo a Emergencia o marca 911. Teléfono no verificado oficialmente.

Fuentes oficiales (bibliografía)

Todo el contenido de esta guía se curó de estas fuentes oficiales y científicas. No reemplaza la atención de un profesional de salud.

American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (AAO-HNS) — Clinical Practice Guideline: Nosebleed (Epistaxis)

<https://www.entnet.org/quality-practice/quality-products/clinical-practice-guidelines/nosebleed-epistaxis/>

American College of Surgeons · Stop the Bleed — Cómo controlar una hemorragia (torniquete)

<https://www.stopthebleed.org/>

American Heart Association (AHA) — RCP solo con las manos (Hands-Only CPR) — Guías 2020

<https://cpr.heart.org/en/resources/what-is-cpr>

American Heart Association (AHA) — Soporte vital básico pediátrico — RCP en niño y bebé

<https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/pediatric-basic-life-support>

American Red Cross — Poison Exposure: Signs, Symptoms, and First Aid

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/poison-exposure>

American Red Cross — Nosebleed (Epistaxis)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/nosebleeds>

American Red Cross (Cruz Roja Americana) — Snake Bites: Symptoms, Causes, and Treatment

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/venomous-snake-bites>

American Red Cross (Cruz Roja Americana) — Concussion: Symptoms, Causes, and Treatment (reposo, llamar al 911, evitar analgésicos, vigilar a la persona)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/concussion>

American Red Cross / Cruz Roja Americana — Smoke Inhalation (first aid guidance)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-pet-first-aid/dog/smoke-inhalation>

CCOHS (Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional) — First Aid - Using an Epinephrine Auto-injector

https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/firstaid/firstaid_epinephrine.html

CDC — Global Hygiene (lavado de manos con jabón al menos 20 segundos; momentos clave)

<https://www.cdc.gov/global-water-sanitation-hygiene/about/about-global-hygiene.html>

CDC — Water Disinfection for Travelers (hervir 1 minuto; SODIS: botella transparente, 6 horas al sol o 2 días si está nublado; aclarar agua turbia primero)

<https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/preparing-international-travelers/water-disinfection-for-travelers.html>

CDC — How to make oral rehydration solution (ORS): 1 litro de agua, 6 cucharaditas rasas de azúcar, 1/2 cucharadita de sal

https://www.cdc.gov/global-water-sanitation-hygiene/media/pdfs/ors_seasia_508.pdf

CDC — Preventing Dengue

<https://www.cdc.gov/dengue/prevention/index.html>

CDC — Manage Dengue (treatment: usar acetaminofén, no aspirina ni ibuprofeno)

<https://www.cdc.gov/dengue/treatment/index.html>

CDC — Severe Dengue: Know the Warning Signs

<https://www.cdc.gov/dengue/stories/severe-dengue.html>

CDC — Preventing Mosquito Bites (repelente, ropa, mallas, mosquiteros)

<https://www.cdc.gov/mosquitoes/prevention/index.html>

CDC — Traumatic Brain Injury & Concussion — Recovering from a Mild Traumatic Brain Injury or Concussion (reposo, vigilancia 24 h, señales de peligro)

https://www.cdc.gov/traumatic-brain-injury/media/pdfs/2024/05/patient_discharge_instructions_ENG-508.pdf

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.) — Emergency Wound Care After a Natural Disaster (Cuidado de heridas de emergencia después de un desastre natural)

<https://www.cdc.gov/natural-disasters/communication-resources/emergency-wound-care-after-a-natural-disaster-factsheet.html>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.) — Safety Guidelines: Floodwater (Heridas abiertas y agua de inundación)

<https://www.cdc.gov/floods/safety/floodwater-after-a-disaster-or-emergency-safety.html>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE. UU.) — About Tetanus / Clinical Guidance for Wound Management to Prevent Tetanus (Tétanos: heridas de riesgo y vacuna)

<https://www.cdc.gov/tetanus/hcp/clinical-guidance/index.html>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EE.UU.) — Cholera — Signs and Symptoms (señales de deshidratación grave y cuándo buscar atención)

<https://www.cdc.gov/cholera/signs-symptoms/index.html>

CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) — **HEADS UP** — Signs and Symptoms of Concussion (señales de peligro, incluye bebés y niños)

<https://www.cdc.gov/heads-up/signs-symptoms/index.html>

CDC (EE.UU.) — Lesiones por aplastamiento tras un terremoto

<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11904>

CDC (EE.UU.) — Mantente seguro después de un terremoto (2024)

<https://www.cdc.gov/earthquakes/safety/stay-safe-after-an-earthquake.html>

CDC (EE.UU.) — Cómo hacer que el agua sea segura en una emergencia

<https://www.cdc.gov/water-emergency/about/index.html>

CDC (EE.UU.) — Mantén los alimentos seguros tras un desastre o emergencia

<https://www.cdc.gov/food-safety/foods/keep-food-safe-after-emergency.html>

CDC (EE.UU.) — Primeros auxilios para convulsiones

<https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html>

CDC / NIOSH — Insects and Scorpions at Work

<https://www.cdc.gov/niosh/outdoor-workers/about/insects-and-scorpions.html>

CICR (Cruz Roja Internacional) — Venezuela — Contáctanos / Sigamos en Contacto

<https://www.icrc.org/es/document/venezuela-contactanos-traves-de-nuestra-linea-de-atencion-telefonica>

Cleveland Clinic — Puncture Wound

<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/puncture-wound>

Cleveland Clinic — 6 Steps To Stop a Nosebleed

<https://health.clevelandclinic.org/how-to-stop-a-nosebleed>

Cleveland Clinic — When To Worry About a Nosebleed: Is It Serious?

<https://health.clevelandclinic.org/do-you-get-too-many-nosebleeds-when-to-worry>

Cleveland Clinic — Smoke Inhalation: Symptoms & When To Be Concerned

<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/smoke-inhalation>

Cruz Roja Americana — Atragantamiento en adultos y niños

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/adult-child-choking>

Cruz Roja Americana — Atragantamiento en bebés

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/infant-choking>

Cruz Roja Americana — Seguridad en terremotos

<https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/earthquake.html>

Cruz Roja Americana — Sangrado externo que amenaza la vida

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/bleeding-life-threatening-external>

Cruz Roja Americana — RCP en niños y bebés

<https://www.redcross.org/take-a-class/cpr/performing-cpr/child-baby-cpr>

Cruz Roja Americana — Convulsiones: primeros auxilios

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/seizures>

Cruz Roja Americana (American Red Cross) — Allergic Reaction / Anaphylaxis: Causes, Symptoms, How To Help

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/allergic-reaction-anaphylaxis>

Cruz Roja Americana (American Red Cross) — Bleeding (Life-Threatening External)

<https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/bleeding-life-threatening-external>

Cruz Roja Venezolana — Sede Nacional — Caracas

<https://cruzroja.ve/>

Electrical Safety Foundation (ESFI) — Seguridad con líneas eléctricas caídas

<https://www.esfi.org/power-lines-safety-tips/>

Epilepsy Foundation — Primeros auxilios para convulsiones (Quédate · Protege · De lado)

<https://www.epilepsy.com/recognition/first-aid-resources>

FoodSafety.gov (HHS, EE.UU.) — Seguridad de los alimentos durante un corte de luz

<https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage>

Great ShakeOut · Earthquake Country Alliance — Agáchese, Cúbrase y Agárrese (Drop, Cover, Hold On)

<https://www.shakeout.org/dropcoverholdon/>

IFRC · Centro de Referencia de Apoyo Psicosocial — Guía de Primeros Auxilios Psicológicos (Observar · Escuchar · Conectar)

<https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Guide-low-res.pdf>

IFRC · Cruz Roja / Media Luna Roja — Guías Internacionales de Primeros Auxilios, Reanimación y Educación 2020

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-02/EN_GFARC_GUIDELINES_2020.pdf

Kaiser Permanente (guía de cuidado basada en consenso CDC) — Concussion (Mild Traumatic Brain Injury): Care Instructions (hielo 10–20 min con paño, no alcohol, vigilar 24 h)

<https://healthy.kaiserpermanente.org/health-wellness/health-encyclopedia/he.concussion-mild-traumatic-brain-injury-care-instructions.uf7532>

Manual MSD (versión para público general) — Inhalación de humo

<https://www.msdmanuals.com/es/hogar/traumatismos-y-envenenamientos/quemaduras/inhalaci%C3%B3n-de-humo>

Mayo Clinic — Sangrado severo: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-severe-bleeding/basics/art-20056661>

Mayo Clinic — Quemaduras: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649>

Mayo Clinic — Fracturas (huesos rotos): primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fractures/basics/art-20056641>

Mayo Clinic — Shock: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-shock/basics/art-20056620>

Mayo Clinic — Desmayo: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fainting/basics/art-20056606>

Mayo Clinic — Lesión de columna: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-spinal-injury/basics/art-20056677>

Mayo Clinic — Golpe de calor: primeros auxilios (2024)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-heatstroke/basics/art-20056655>

Mayo Clinic — Descarga eléctrica: primeros auxilios

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-electrical-shock/basics/art-20056695>

Mayo Clinic — Anaphylaxis: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-anaphylaxis/basics/art-20056608>

Mayo Clinic — Poisoning: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-poisoning/basics/art-20056657>

Mayo Clinic — Snakebites: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-snake-bites/basics/art-20056681>

Mayo Clinic — Foreign object in the skin: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid/basics/art-20056604>

Mayo Clinic — Puncture wounds: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-puncture-wounds/basics/art-20056665>

Mayo Clinic — Head trauma: First aid (mantener quieto, no mover el cuello, pupila desigual, líquido por nariz/oídos)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-head-trauma/basics/art-20056626>

Mayo Clinic — Nosebleeds: First aid

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-nosebleeds/basics/art-20056683>

Mayo Clinic — Cuts and scrapes: First aid (Cortes y raspones: primeros auxilios)

<https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cuts/basics/art-20056711>

MedlinePlus (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) — Inhalation Injuries / Lesiones por inhalación

<https://medlineplus.gov/inhalationinjuries.html>

Merck Manual (Consumer Version) — Caustic Chemicals Poisoning

<https://www.merckmanuals.com/home/injuries-and-poisoning/poisoning/caustic-chemicals-poisoning>

OMS (Organización Mundial de la Salud) — Prevention and management of wound infection (Prevención y manejo de la infección de heridas)

<https://www.who.int/publications/i/item/prevention-and-management-of-wound-infection>

OMS (WHO) — Dengue and severe dengue — Fact sheet

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

OMS / Humanitarian Health Care Manual (NCBI Bookshelf) — Diarrhoea and dehydration – señales de deshidratación, cantidades de suero tras cada evacuación y qué hacer si vomita

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143745/>

OMS / UNICEF — WHO/UNICEF Joint Statement: Clinical Management of Acute Diarrhoea (SRO de baja osmolaridad + zinc, seguir alimentando)

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/07/WHO-UNICEF_Joint-Statement_clinical-management-of-acute-diarrhoea.pdf

OMS / WHO — Métodos de tratamiento del agua y su desempeño

<https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/water-safety-and-quality/drinking-water-quality-guidelines>

OMS / WHO — Primeros auxilios psicológicos: guía para trabajadores de campo (2011)

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241548205>

OMS / WHO — Cholera (fact sheet): WASH, lavado de manos con jabón, agua y alimentos seguros, disposición segura de heces, y atención urgente ante diarrea acuosa grave

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera>

OMS / WHO — Five keys to safer food (Cinco claves para la inocuidad de los alimentos)

<https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling/five-key-to-safer-food>

OPS / OMS — Observar, escuchar y conectar: cuidado de la salud mental

<https://www.paho.org/es/noticias/12-6-2020-observar-escuchar-conectar-clave-para-cuidado-mutuo-salud-mental>

OPS / PAHO — PAHO/WHO recommends five keys to safer food (separar crudo/cocido, cocer bien, no dejar comida >2h, agua segura)

<https://www.paho.org/en/news/21-12-2015-pahowho-recommends-five-keys-safer-food-healthy-holiday-season>

OPS/OMS (PAHO) — Dengue: síntomas, prevención y tratamiento (Dengue topic page)

<https://www.paho.org/en/topics/dengue>

OPS/OMS (PAHO) — Vector Control in Disaster Situations

<https://www.paho.org/en/health-emergencies/vector-control-disaster-situations>

Organización Mundial de la Salud (OMS) — Snakebite envenoming

<https://www.who.int/health-topics/snakebite>

Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) — Cholera outbreaks – Q&A (receta de suero oral casero: 1 litro de agua segura, 6 cucharaditas de azúcar y media cucharadita de sal)

<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cholera-outbreaks>

Poison Control (America's Poison Centers) — First Aid: Act Fast!

<https://www.poison.org/first-aid-for-poisonings>

Poison Help (HRSA) — Calling Poison Help: What to have ready

<https://poisonhelp.hrsa.gov/faq/calling-poison-help>

Protección Civil Venezuela · FUNVISIS — Guía de tres fases: qué hacer antes, durante y después de un sismo

<https://www.mpprijp.gob.ve/prensa/reporte/conozca-la-guia-de-tres-fases-sobre-que-hacer-antes-durante-y-despues-de-un-sismo>

Ready.gov / FEMA (EE.UU.) — Arma tu kit de emergencia (Build A Kit)

<https://www.ready.gov/kit>

Sphere / Emergency WASH (basado en OMS) — Minimum standards in Water Supply, Sanitation and Hygiene: letrinas a ≥ 30 m de fuentes de agua

<https://handbook.spherestandards.org/>

St John Ambulance — Posición de recuperación

<https://www.sja.org.uk/first-aid-advice/recovery-position/>

St John Ambulance (St John Victoria) — How to provide first aid to a major wound

<https://www.stjohnvic.com.au/news/provide-first-aid-major-wound/>

UNICEF Supply Division — Oral rehydration salts (ORS) and zinc – uso de SRO y zinc en diarrea infantil

<https://www.unicef.org/supply/oral-rehydration-salts-ors-and-zinc>

Universidad Central de Venezuela (UCV) - SOS Telemedicina — Escorpiones: ¿Qué hacer en caso de emponzoñamiento?

https://sosteledicina.ucv.ve/escorpio/escorpio.php?module=aspectos_des&id=10

US EPA — Desinfección de emergencia del agua potable

<https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/emergency-disinfection-drinking-water>

Ven 911 (oficial) — Línea Única de Emergencia VEN 9-1-1

<https://ven911.gob.ve/>

World Allergy Organization (WAO) — World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7607509/>